

CAPÍTULO 13.59

Laringitis Aguda

PERFIL EUNACOM 1.09.1.011

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción y Etiología

La **Laringitis Aguda** es una de las patologías respiratorias más frecuentes en la práctica clínica. Se define como la inflamación de la laringe, generalmente de origen infeccioso.

- **Causa principal:** Virus respiratorios, siendo el **Virus Parainfluenza** el agente etiológico más común.
- **Otros agentes:** Virus Influenza, Adenovirus, VRS.
- **Población objetivo:** La variante obstructiva (Crup) afecta predominantemente a niños entre **6 meses y 3 años**.

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología se basa en el edema de la mucosa laríngea y subglótica. Debido a que la vía aérea del niño es anatómicamente más estrecha, un pequeño grado de inflamación produce un aumento significativo de la resistencia al flujo de aire (Ley de Poiseuille).

Cuadro Clínico

La tríada clásica y los síntomas acompañantes permiten diferenciar la localización de la infección:

- **Disfonía:** Es el síntoma cardinal que diferencia la laringitis de otras infecciones respiratorias altas.
- **Tos:** En la laringitis obstructiva es característica la "**tos de perro**" (tos crupal o metálica).
- **Estridor:** Generalmente **inspiratorio**, aunque puede ser bifásico en casos severos.
- **Fiebre y Mialgias:** Como parte del pródromo viral.

Exploración Física

- El examen pulmonar suele ser **normal**, ya que es una afección de la vía aérea superior. - Se debe buscar activamente signos de **uso de musculatura accesoria** (retracción intercostal, supraclavicular) y cianosis en casos graves.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: Ante un paciente con estridor, siempre considera el diagnóstico diferencial con **Epiglotitis** (el niño luce más tóxico, con sialorrea y sin tos de perro) y con el **Cuerpo Extraño en Vía Aérea**.

Diagnóstico

El diagnóstico es **absolutamente clínico**. No se requieren exámenes de rutina para iniciar el manejo.

- **Radiografía de cuello (AP):** Puede mostrar el "**Signo de la punta de lápiz**" (estrechamiento subglótico). No es necesaria a menos que existan dudas diagnósticas.
- **Hemograma:** Podría mostrar linfocitosis (sugere de etiología viral), pero no cambia la conducta.

Clasificación de Severidad (Score de Wesley)

Se utiliza para guiar el tratamiento según el grado de obstrucción:

TABLA 13.59.1: GRADO VS HALLAZGOS CLÍNICOS

GRADO	HALLAZGOS CLÍNICOS	MANEJO SUGERIDO
Grado 1	Sin obstrucción. Estridor leve solo con agitación.	Sintomático + Corticoide oral.
Grado 2	Estridor de reposo. Sin agitación.	Adrenalina nebulizada + Corticoide.
Grado 3	Estridor de reposo + Agitación/Angustia.	Adrenalina + Corticoide + Oxígeno. Evaluar hospitalización.
Grado 4	Falla respiratoria, cianosis, compromiso de conciencia.	Intubación + UCI.

NOTA CLÍNICA

Si un paciente llega a la urgencia y los padres refieren que "estaba muy mal en casa pero se mejoró en el camino con el aire fresco", se clasifica y maneja como **Grado 1**.

Tratamiento

1. Medidas Generales

- **Sintomáticos:** Paracetamol o AINEs para la fiebre y el malestar. - **Aire frío:** Clásicamente recomendado, pero **no tiene evidencia sólida** de efectividad y conlleva riesgo de hipotermia en lactantes.

2. Corticoides

Su objetivo es disminuir la inflamación y prevenir la recurrencia o progresión de la obstrucción. - **Dexametasona:** Dosis de **0,6 mg/kg** (vía oral o intramuscular). Es el estándar de oro. - En adultos (profesores, cantantes), su uso puede acortar la duración de la disfonía.

3. Adrenalina Nebulizada

Indicada en **Grado 2 o superior** (estridor de reposo). Produce vasoconstricción local y reduce el edema rápidamente.

TABLA 13.59.2: TIPO DE ADRENALINA VS DOSIS

TIPO DE ADRENALINA	DOSIS
Adrenalina Racémica	0,05 ml/kg de peso.
Adrenalina Corriente (L-epinefrina)	0,5 ml/kg de peso (Dosis máxima 5 ml).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El efecto de la adrenalina es transitorio (aprox. 2 horas). El paciente debe ser observado en urgencias para evitar el "**efecto rebote**" una vez que pase el efecto del fármaco.

4. Manejo de la Vía Aérea (Grado 4)

En caso de falla respiratoria inminente: - Requiere **intubación endotraqueal** por personal experto (anestesta o intensivista). - Se debe usar un **tubo de menor calibre** al calculado para la edad, debido al edema de la laringe.

Complicaciones y Seguimiento

- **Sobreinfección bacteriana:** Sospechar si el paciente vuelve a presentar fiebre alta, aspecto tóxico o expectoración mucopurulenta tras una mejoría inicial. - **Laringitis recurrente:** Si el paciente presenta cuadros obstructivos a repetición, se debe derivar para estudio con nasofibrolaringoscopia para descartar malformaciones o causas obstructivas anatómicas.

EUNACOM CRITERIOS

No se indican antibióticos de forma rutinaria, ya que la etiología es viral en la gran mayoría de los casos.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Un niño de 18 meses es llevado a urgencias con tos perruna, disfonía y estridor audible en reposo de 12 horas de evolución. Presenta fiebre de 38.5 grados. No se observa tiraje intercostal ni agitación. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Laringitis Aguda. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La laringitis aguda es causada principalmente por virus parainfluenza; diagnóstico y tratamiento son clínicos y sintomáticos
- La disfonía es el síntoma que diferencia la laringitis de otras infecciones respiratorias altas
- La laringitis obstructiva (crup viral) afecta típicamente a niños de 6 meses a 3 años
- Clínica del crup viral: tos perruna, disfonía y estridor inspiratorio
- Score de Wesley: grado 1 (sin obstrucción), grado 2 (estridor de reposo), grado 3 (agitación), grado 4 (falla respiratoria)
- Grado 2: adrenalina nebulizada + dexametasona 0.6 mg/kg (lo más preguntado)
- Adrenalina racémica 0.05 ml/kg o adrenalina común 0.5 ml/kg (10 veces la dosis de la racémica)
- Grado 4: intubación por especialista con tubo más pequeño del esperado, manejo en UCI
- Radiografía de cuello: signo de la punta de lápiz (diferente al signo del pulgar de la epiglotitis)
- El estudio se realiza solo cuando es recurrente, buscando causas obstructivas

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (LARINGITIS AGUDA)**PREGUNTA 1**

Un niño de 18 meses es llevado a urgencias con tos perruna, disfonía y estridor audible en reposo de 12 horas de evolución. Presenta fiebre de 38.5 grados. No se observa tiraje intercostal ni agitación. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?

- A)** Tratamiento sintomático con paracetamol y observación domiciliaria
- B)** Adrenalina nebulizada más dexametasona 0.6 mg/kg
- C)** Antibióticos endovenosos por sospecha de epiglotitis
- D)** Intubación endotraqueal inmediata y traslado a UCI
- E)** Radiografía de cuello y hemograma antes de decidir tratamiento

PREGUNTA 2

Un niño de 2 años es traído a urgencias por su madre, quien refiere que en la casa estaba con mucha dificultad respiratoria, tos perruna y estridor, pero durante el trayecto al hospital los síntomas mejoraron significativamente. Al momento de la evaluación, el niño se encuentra tranquilo, sin estridor y con examen físico normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Alta sin indicaciones, ya que se encuentra asintomático
- B)** Hospitalizar para observación de 24 horas
- C)** Tratamiento sintomático y considerar dexametasona para prevenir recurrencia
- D)** Adrenalina nebulizada de forma inmediata a pesar de estar asintomático
- E)** Solicitar radiografía de cuello para descartar epiglotitis

PREGUNTA 3

En relación a la laringitis obstructiva grado 4, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

- A)** Se maneja exclusivamente con adrenalina nebulizada a doble dosis
- B)** La intubación debe realizarla cualquier médico disponible de forma inmediata
- C)** Se utiliza un tubo endotraqueal del tamaño esperado para la edad
- D)** La intubación debe ser realizada por un especialista y con un tubo más pequeño del esperado
- E)** El manejo inicial es con corticoides orales y observación en sala común

RESUMEN: LARINGITIS AGUDA

Esta clase aborda la laringitis aguda y su variante obstructiva (crup viral). La laringitis aguda es una infección respiratoria alta muy frecuente causada principalmente por el virus parainfluenza. Se presenta con tos y disfonía (que la diferencia de otras infecciones respiratorias altas), puede acompañarse de fiebre, y el examen pulmonar es habitualmente normal. El diagnóstico es clínico y el tratamiento es sintomático. Los corticoides pueden acortar la duración de la disfonía pero solo se indican en pacientes que necesitan recuperar su voz rápidamente (cantantes, profesores). La laringitis obstructiva o crup viral es la variante con compromiso de la vía aérea, causada igualmente por parainfluenza. Afecta típicamente a niños entre 6 meses y 3 años, con tos perruna, disfonía y estridor inspiratorio. Se clasifica en 4 grados según el score de Wesley: grado 1 (sin obstrucción), grado 2 (estridor de reposo), grado 3 (agitación) y grado 4 (falla respiratoria). El tratamiento se basa en la severidad: grado 1 con tratamiento sintomático y eventualmente dexametasona para prevenir recurrencia; grado 2 con adrenalina nebulizada (racémica 0.05 ml/kg o común 0.5 ml/kg) más dexametasona 0.6 mg/kg; grado 3 similar al grado 2 más oxígeno y evaluación de hospitalización; grado 4 requiere intubación por especialista con tubo más pequeño del esperado y manejo en UCI. La radiografía de cuello puede mostrar el signo de la punta de lápiz. Los antibióticos solo se indican si se sospecha sobreinfección bacteriana.